



**UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

FACULTAD DE CIENCIA DE LASALUD
Introducción a la Psicología Clínica de la Niñez y Adolescencia.

TRASTORNO DE ELIMINACIÓN

Autor: Ricardo Fruto

Cédula: 8-728-2138

Panamá, 09 de mayo de 2026

CONTEXTUALIZACIÓN

CUIDAR LA AUTOESTIMA



"Secar las sábanas es fácil; sanar la autoestima de un niño avergonzado requiere mucha más paciencia."

AA

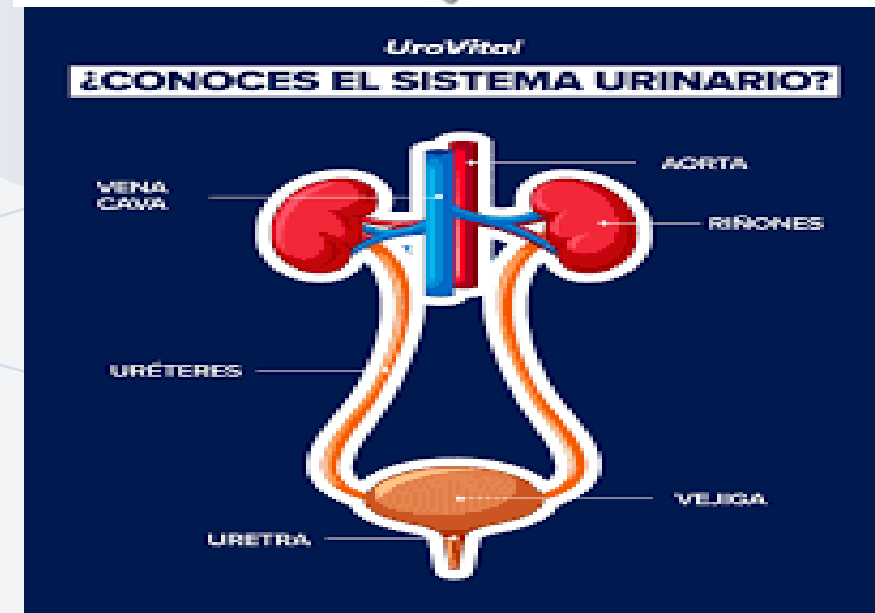
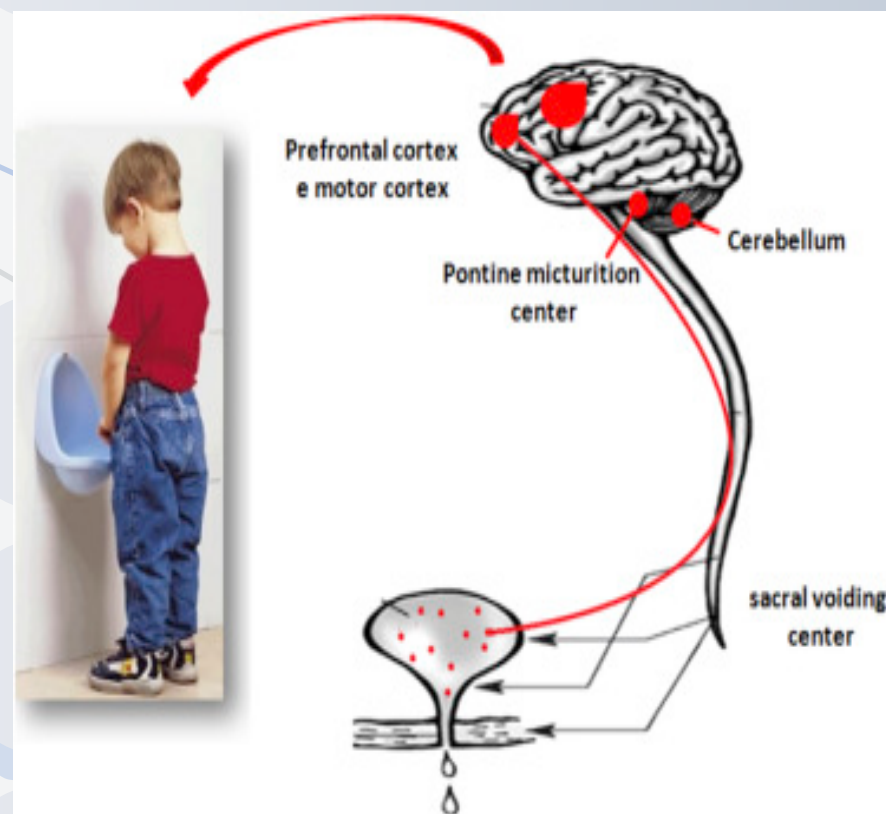


Incapacidad de controlar la emisión de orina o heces en lugares inadecuados, una vez que el niño ha alcanzado la edad madurativa necesaria para el control de esfínteres

4 – 5
AÑOS

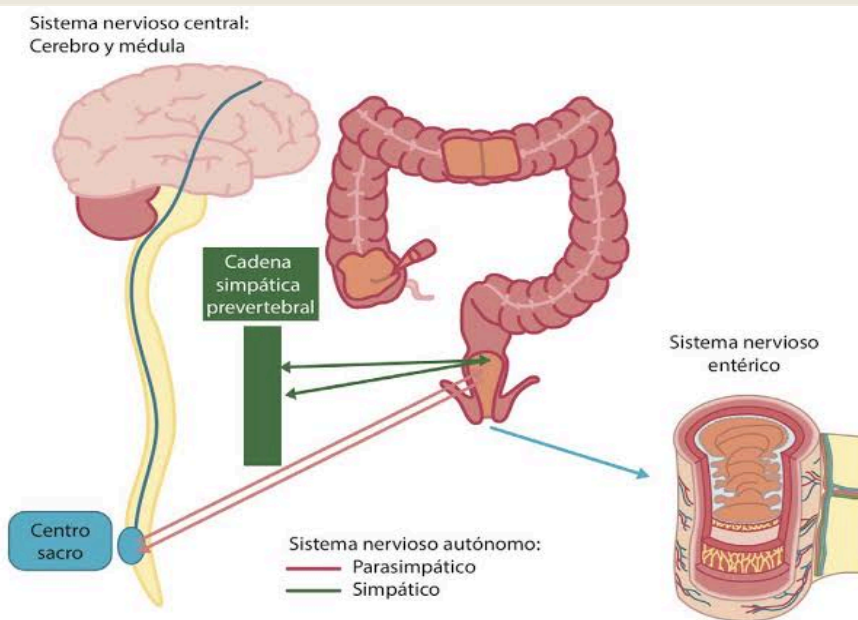
ENURESIS

:



PROCESO DE MICCION Y PROCESO DE EVACUACION FECAL

ENCOPRESIS



ETIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS DE ELIMINACIÓN



Biológicas: Antecedentes familiares, desequilibrios hormonales (como la vasopresina) o estreñimiento crónico grave.

Psicológicas: Estrés emocional por divorcios, mudanzas o la llegada de un hermano.

Aprendizaje: Entrenamiento de esfínteres demasiado temprano, rígido o conflictivo.





CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

CRITERIO

Enuresis (Orina)

Encopresis (Heces)

DEFINICIÓN

Emisión repetida de orina en la cama o la ropa, sea voluntaria o involuntaria.

Excreción repetida de heces en lugares inapropiados (ej. ropa o suelo), voluntaria o involuntaria.

FRECUENCIA

Al menos 2 veces por semana durante un mínimo de 3 meses consecutivos.

Al menos 1 vez al mes durante un mínimo de 3 meses consecutivos.

EDAD MÍNIMA

Por lo menos 5 años de edad (o nivel de desarrollo equivalente).

Por lo menos 4 años de edad (o nivel de desarrollo equivalente).

EXCLUSIONES

El comportamiento no se debe atribuir a efectos de sustancias (diuréticos) o afecciones médicas (diabetes, espina bífida).

El comportamiento no se debe atribuir a efectos de sustancias (laxantes) ni afecciones médicas (excepto estreñimiento).

ESPECIFICADOR ES

- Nocturna: Solo durante el sueño.
- Diurna: Solo en vigilia.
- Mixta: Ambos casos.

- **Con estreñimiento e incontinencia por rebordamiento.**
- **Sin estreñimiento e incontinencia por rebordamiento.**



DIFERENCIACIÓN DSM5 vs CIE 11

CARACTERÍSTICA

DSM – 5

CIE – 11

CATEGORIZACIÓN

Se agrupan bajo el capítulo de Trastornos de la eliminación.

Se agrupan bajo Trastornos mentales, del comportamiento o del neurodesarrollo. Se catalogan como Desordenes de Eliminación.

ENFOQUE DE DIAGNÓSTICO

Más rígido y basado en criterios de frecuencia y tiempo.

Más flexible y basado en el juicio clínico y el impacto en la vida del paciente.

CÓDIGOS

Utiliza códigos alfanuméricos; F98.0 para Enuresis y F98.1 para Encopresis.

Utiliza una estructura nueva; 6C00 para Enuresis y 6C01 para Encopresis.

ENURESIS

DSM-5

CIE-11

EDAD MÍNIMA

A los 5 años o nivel de desarrollo equivalente.

Edad de desarrollo Urinaria, normalmente esperado a los 5 años

FRECUENCIA

Al menos 2 veces por semana durante 3 meses.

No define un número exacto de incidentes; se centra en el malestar significativo o deterioro funcional.

ENCOPRESIS

DSM-5

CIE-11

EDAD MÍNIMA

A los 4 años o nivel de desarrollo equivalente.

Edad de desarrollo Fecal, normalmente esperado a los 4 años

FRECUENCIA

Al menos 1 vez por mes durante 3 meses.

Al menos 1 vez por mes durante varios meses.

SUBTIPOS DE ENCOPRESIS

Clasifica según, si existe o no estreñimiento e incontinencia por rebordamiento.

Los separa si existe o no estreñimiento e incontinencia por desbordamiento.



ESTADÍSTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES



Región / Organismo	Trastorno	Prevalencia / Cifras Clave	Observaciones del Contexto
Internacional (OMS / OPS)	Enuresis	15% a 20% en niños de 5 años; disminuye al 1% - 2% en la adolescencia.	Se asocia con una brecha de tratamiento del 78% en la región de las Américas.
Internacional (OMS / OPS)	Encopresis	1.5% a 8% en población pediátrica general.	Es 2 veces más frecuente en varones que en mujeres.
Panamá (MINSA)	General (Eliminación)	Proyección de 7% a 10% en edad escolar inicial.	Muchos casos se reportan como "problemas de conducta" o ansiedad antes del diagnóstico.
Panamá (IPHE)	Atención Especializada	17,263 estudiantes atendidos anualmente (Corte 2022).	El IPHE brinda apoyo técnico (psicología/médico) a niños con estas condiciones en escuelas inclusivas.
Panamá (MINSA)	Comorbilidad	25% a 40% de los casos.	Los TE suelen presentarse junto con TDAH o Trastorno de Conducta.



ESTADÍSTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES



Región /
Organismo

Trastorno

Prevalencia / Cifras Clave

Observaciones del Contexto

**Internacional
(OMS / OPS)**

Enuresis

15% a 20% en niños de 5 años; disminuye al 1% - 2% en la adolescencia.

Se asocia con una brecha de tratamiento del 78% en la región de las Américas.

**Internacional
(OMS / OPS)**

Encopresis

1.5% a 8% en población pediátrica general.

Es 2 veces más frecuente en varones que en mujeres.

**Panamá
(MINSA)**

General
(Eliminación)

Proyección de 7% a 10% en edad escolar inicial.

Muchos casos se reportan como "problemas de conducta" o ansiedad antes del diagnóstico.

**Panamá
(MINSA)**

Comorbilidad

25% a 40% de los casos.

Los TE suelen presentarse junto con TDAH o Trastorno de Conducta.



ESTADÍSTICAS – DSM 5 TR

Importación

Enuresis (Control de Orina)

Encopresis (Control de Heces)

Edad mínima diagnóstica	5 años cronológicos o de desarrollo.	4 años cronológicos o de desarrollo.
Prevalencia a los 5 años	5% – 10% de la población infantil.	Aproximadamente 1% .
Prevalencia a los 10 años	3% – 5% de los niños.	Menos del 1% .
Prevalencia en adolescentes	1% (mayores de 15 años).	Muy infrecuente (<1%).
Relación por Sexo (V:M)	2: 1 (Más común en varones).	3:1 (Predominio masculino marcado).
Tasa de remisión anual	15% de resolución espontánea.	Variable, suele mejorar con la edad



El abordaje suele ser multidisciplinar, combinando la medicina y la psicología:

TRATAMIENTO PARA EL TX DE ELIMINACIÓN

Entrenamiento de Esfínteres

Terapia de Alarma.

Terapias Cognitivo . conductual

Terapias Familiares, dietas, medicamentos





Resumen de la Investigación: Tratamiento Psicológico de la Encopresis Infantil



ASPECTO

DETALLE DE LA INVESTIGACIÓN

Título

Tratamiento psicológico aplicado a niños con encopresis.

Objetivo

Describir el tratamiento psicológico aplicado a niños con este trastorno.

Metodología

Estudio descriptivo, de corte transversal con enfoque cualitativo realizado en el Hospital Pediátrico Provincial “Eduardo Agramonte Piña” (Camagüey, Cuba) entre mayo 2019 y enero 2020.

Muestra

26 niños en etapa escolar, con edades comprendidas entre los 4 y los 9 años, sin causas orgánicas asociadas.

Estructura del Tratamiento

Se dividió en tres momentos principales:

1. Recepción y evaluación: Recogida de datos y aplicación de tests proyectivos.
2. Hábito eliminatorio: Compromiso del niño, organización de horarios, uso de almanaques y técnicas conductuales (reforzamiento positivo y economía de fichas).
3. Seguimiento y orientación: Psicoterapia individual y dinámica familiar según los conflictos detectados.

Las áreas de mayor conflicto fueron la familiar (divorcio mal manejado en un 38,4%), la individual (demanda de afecto materno en un 30.7%) y la escolar (dificultades de aprendizaje en un 26.9%).

Conflictos Detectados

El tratamiento efectivo requiere acciones terapéuticas para desarrollar el hábito, intervención con los padres para mejorar la comunicación, fomentar la independencia del niño y atender dificultades escolares.

Conclusiones



Famosos que han padecido Tx. De Eliminación



FAMOSO

DETALLE DIAGNÓSTICO

IMPACTO Y MENSAJE



Michael Phelps, nadador olímpico ha confesado que mojaba la cama (**enuresis**) hasta bien entrada su infancia.



Sarah Silverman, comediente estadounidense ha sido muy abierta sobre sufrir **enuresis nocturna** hasta los **16 años**.



Mark Ruffalo, actor (Hulk) ha mencionado en entrevistas haber tenido problemas de control de esfínteres en su niñez.



Vince Vaughn, actor ha bromeado y confesado en entrevistas que mojaba la cama hasta una edad avanzada (pre-adolescencia).



Suzanne Somers, actriz relató en su biografía que mojaba la cama debido al **estrés extremo** de vivir en un hogar con un padre alcohólico.

Lo asocia a su diagnóstico de **TDAH**. Ha compartido que esto afectó su confianza inicial, pero que el deporte fue su vía de escape.

En sus memorias y entrevistas, relata la vergüenza extrema que sentía en los campamentos y cómo esto influyó en su personalidad defensiva y sentido del humor.

Lo vincula con periodos de alta **ansiedad y estrés familiar** durante su desarrollo temprano, reforzando la idea de que es un síntoma emocional.

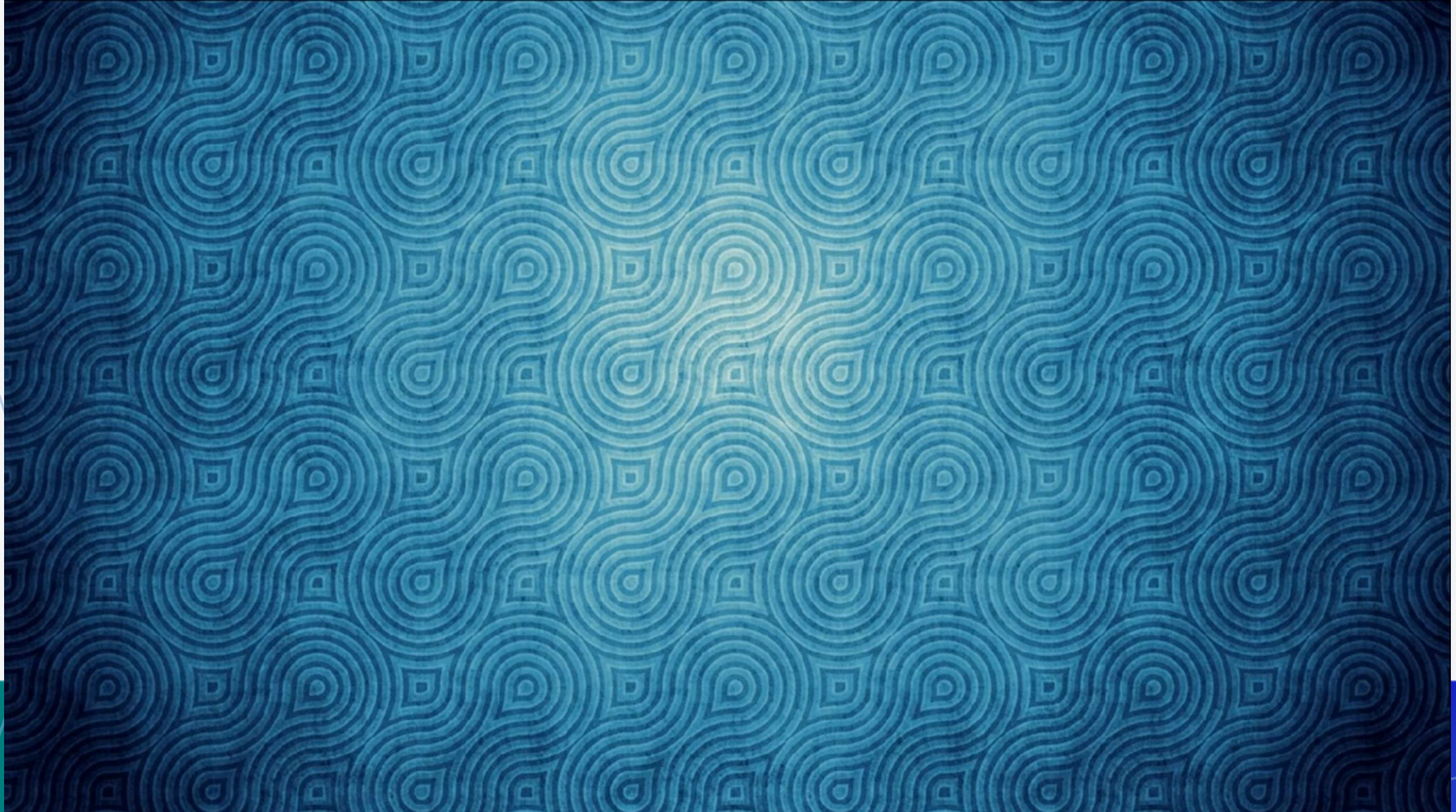
Suele utilizar su experiencia para restar importancia al estigma y mostrar que es un proceso de maduración que no define el éxito futuro.

Este caso ejemplifica perfectamente que un **estilo de crianza autoritario** o disfuncional dispara trastornos de eliminación.





VIDEO





REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



1

Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) (5.^a ed.). Editorial Médica Panamericana.

5

Sánchez-Morales, G., & García-López, R. (2017). Tratamiento médico de la enuresis en niños: aspectos actuales. Revista de la Facultad de Medicina (México), 60(3), 22-31.

2

Organización Mundial de la Salud. (2022). *Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud* (11.^a ed.). <https://icd.who.int/browse11/l-m/es>

3

Pérez Ramos, L., Martínez de la Coteria, A., & García, M. (2022). Encopresis en niños atendidos en consulta externa de psiquiatría infantil. Revista Cubana de Pediatría, 94(1), e1654. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312022000100020

4

Pérez Ramos, L., & Valdés Rodríguez, M. (2024). La enuresis, un problema a enfrentar desde la Atención Primaria de Salud por su componente educativo. Revista Cubana de Pediatría, 96, e2368. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2709-79272024000100007



MUCHAS
GRACIAS

